ERGO SANITAS

SALUD DOMICILIARIA Y DEPORTIVA

PARA EL PACIENTE Y EL DEPORTISTA

Tu ficha clínica en línea

Todos tus exámenes en un solo lugar: signos vitales, composición corporal, electrocardiogramas y un asistente al que le puedes preguntar. Entras con tu usuario desde el teléfono o el computador, cuando quieras.

Este documento recorre la ficha pantalla por pantalla, con imágenes reales de la plataforma. El nombre y el RUT del paciente del ejemplo fueron reemplazados; todas las cifras son las de sus exámenes verdaderos.

1 Dónde están hoy tus exámenes

Probablemente en una carpeta, un correo y un cajón.

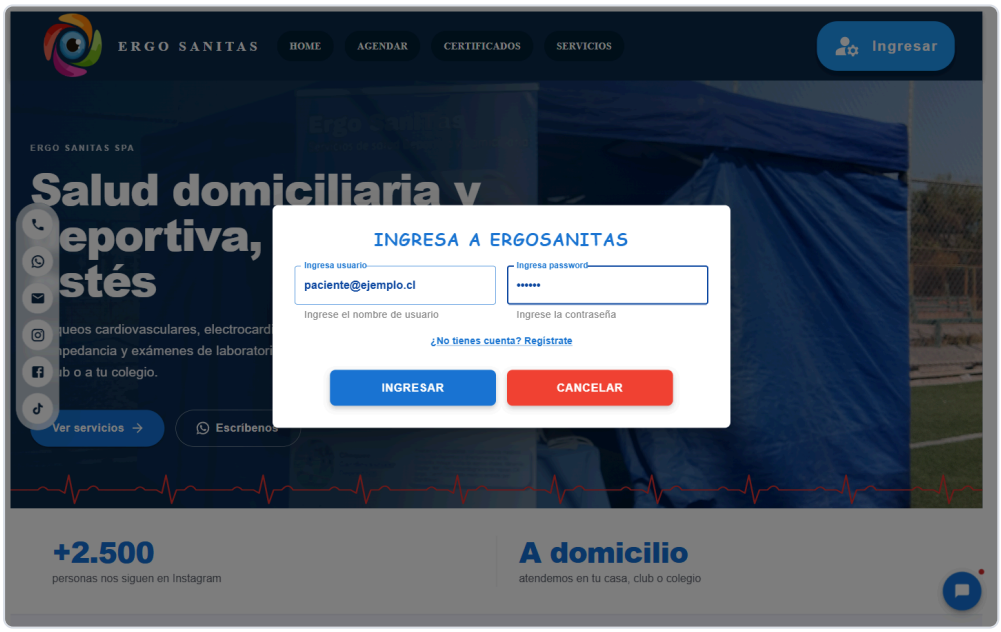
Te tomas un examen y recibes una hoja. La hoja va a una carpeta, la carpeta a un cajón, y cuando el médico pregunta «¿cómo estabas hace un año?» nadie lo sabe. El examen siguiente vuelve a partir de cero, y lo que costó medir no se puede comparar con nada.

La ficha clínica de Ergo SaniTas es lo contrario: **un solo lugar donde queda todo lo que te medimos**, con tu usuario, para siempre. No es un archivo que te mandamos por correo: es una ficha que se actualiza sola cada vez que te atendemos.

> **LO QUE CAMBIA EN LA PRÁCTICA**
>
> Dejas de ser el encargado de guardar tus propios papeles. Y cuando vas al médico, al nutricionista o al preparador físico, **llegas con datos** en vez de con recuerdos.

Cómo entras

Con el usuario que te entregamos, desde cualquier navegador. No hay que instalar nada ni pagar una aplicación.



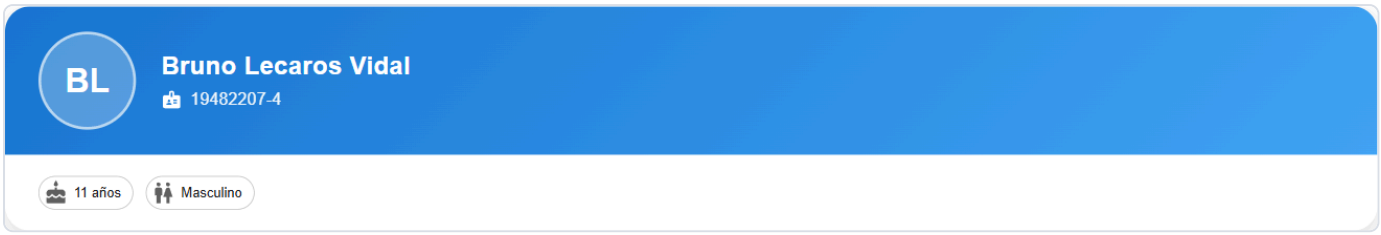
Acceso. Cada paciente tiene su propio usuario, y ve únicamente su ficha.

Las cinco pestañas

Pestaña	Qué encuentras
Home	Cómo estás hoy: los signos vitales de tu último control y tu evaluación nutricional.
Bioimpedancias	De qué está hecho tu cuerpo: grasa, músculo, agua, hueso y metabolismo.
Electrocardiogramas	Tu corazón: la lectura del médico y la evaluación por sistema.
Distribución Segmentaria	Dónde está cada kilo, sobre una figura del cuerpo.
Asistente Ergo	Un asistente al que le preguntas por tu ficha, escribiendo o hablando.

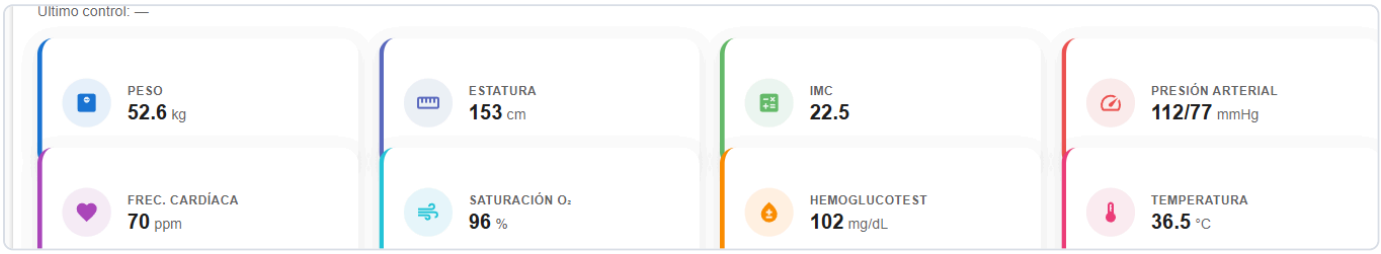
2 Cómo estás hoy

La primera pantalla. Se lee en diez segundos.



Tu ficha te reconoce. Nombre, RUT, edad y sexo. Todo lo que viene abajo es tuyo y de nadie más.

Debajo, los **signos vitales de tu último control**: ocho mediciones con su unidad, sin tener que interpretar una hoja de laboratorio.



Signos vitales. Peso, estatura, IMC, presión arterial, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, glicemia capilar y temperatura, con la fecha del control cuando quedó registrada.

Y tu evaluación



Evaluación. A la izquierda, tu IMC situado sobre los cuatro rangos de la OMS —bajo peso, normal, sobrepeso, obesidad— con el tuyo destacado. A la derecha, los antecedentes que declaraste: enfermedades crónicas, medicamentos diarios y enfermedades anteriores.

UN DETALLE QUE CONVIENE SABER LEER

El gráfico usa los **rangos de adulto de la OMS**, y lo dice bajo el título. En el ejemplo, un IMC de 22,5 cae en «Normal» con ese criterio, mientras que el propio equipo de bioimpedancia —que usa otros cortes— clasifica el mismo cuerpo como «Sobrepeso». No es un error: son dos referencias distintas. **En un niño o adolescente la evaluación se hace por percentiles según edad y sexo, y eso lo interpreta el pediatra.**

3 De qué está hecho tu cuerpo

La bioimpedancia: lo que la pesa no te puede decir.

Una pesa te da un número: cuánto pesas. No te dice cuánto de eso es músculo y cuánto es grasa, ni dónde está repartida, ni si el peso que bajaste el último mes salió de donde querías. El IMC tiene el mismo problema: **trata igual un kilo de grasa y un kilo de músculo**.

La bioimpedancia resuelve eso. Hace pasar una corriente imperceptible por el cuerpo y mide la resistencia de cada tejido: el músculo, con mucha agua, conduce bien; la grasa, con poca, conduce mal. De esa diferencia salen unas **treinta mediciones**. No pincha, no duele y no hay radiación, y se toma en tu casa, tu club o tu colegio.

Fecha	IMC	Peso	Grasa corporal	Tipo corporal
25/08/2026	22.5	52.6 kg	23.5 %	Sobrepeso

Composición corporal

Grasa corporal **23.5 %**	Masa grasa **12.4 kg**	Grasa subcutánea **16.8 %**
Grasa visceral **4**	Agua corporal total **29.5 kg**	Proteínas **8 kg**
Minerales **—**		

Masa muscular

Masa muscular **37.5 kg**	Músculo esquelético **21.9 kg**	SMI **7.2**
Masa libre de grasa **40.2 kg**		

Distribución segmentaria (medida por el equipo)

Grasa tronco **6.5 kg**	Músculo tronco **17.4 kg**	Grasa brazo izq. **0.7 kg**
Músculo brazo izq. **2 kg**	Grasa brazo der. **0.7 kg**	Músculo brazo der. **2 kg**
Grasa pierna izq. **2.1 kg**	Músculo pierna izq. **6.4 kg**	Grasa pierna der. **2.1 kg**
Músculo pierna der. **6.4 kg**		

Metabolismo y metas

Tasa metabólica basal **1238 kcal**	Edad corporal **10 años**	Puntaje corporal **75**
Peso objetivo **47.4 kg**	Control de peso **-5.2 kg**	Control de grasa **-5.2 kg**
Control de músculo **0 kg**	Índice cintura-cadera **0.81**	

Estatura: 153 cm Hora: 20:09 Equipo: Fitdays Extracción: buena Asimetrías: —

Un examen real, desplegado. Arriba la fila resumen —fecha, IMC, peso, grasa corporal, tipo corporal—; al abrirla, el examen entero en cuatro bloques, y al pie la trazabilidad: estatura, hora, equipo usado y calidad de la lectura.

Qué significa cada bloque

Composición corporal

De qué está hecho el cuerpo: kilos de grasa, agua corporal total, proteínas y minerales. Y dos cifras que la pesa jamás da: la **grasa subcutánea** —la de debajo de la piel— y la **grasa visceral**, la que rodea los órganos, que es la que más importa para el riesgo cardiovascular y metabólico.

Masa muscular

Cuánto músculo hay, incluido el **SMI** (índice de masa musculoesquelética), que es la referencia con la que los especialistas evalúan si la masa muscular es suficiente para la estatura de la persona.

Distribución por extremidad

Grasa y músculo **medidos** en cada brazo, cada pierna y el tronco. Diez cifras, no una estimación.

Metabolismo y metas

Cuántas calorías gasta tu cuerpo en reposo (**tasa metabólica basal**), la **edad corporal** —la que sugiere tu composición, que puede estar por encima o por debajo de la real— y el plan: peso objetivo y cuánto debería cambiar la grasa y cuánto el músculo.

> **POR QUÉ EL PLAN ES LA PARTE ÚTIL**
>
> En el examen del ejemplo el objetivo no es «bajar 5,2 kg». Es **bajar 5,2 kg de grasa y no perder músculo** —control de grasa −5,2 kg, control de músculo 0 kg—. Son dos indicaciones distintas, y sin bioimpedancia no se pueden separar: en la pesa los dos casos se ven igual.

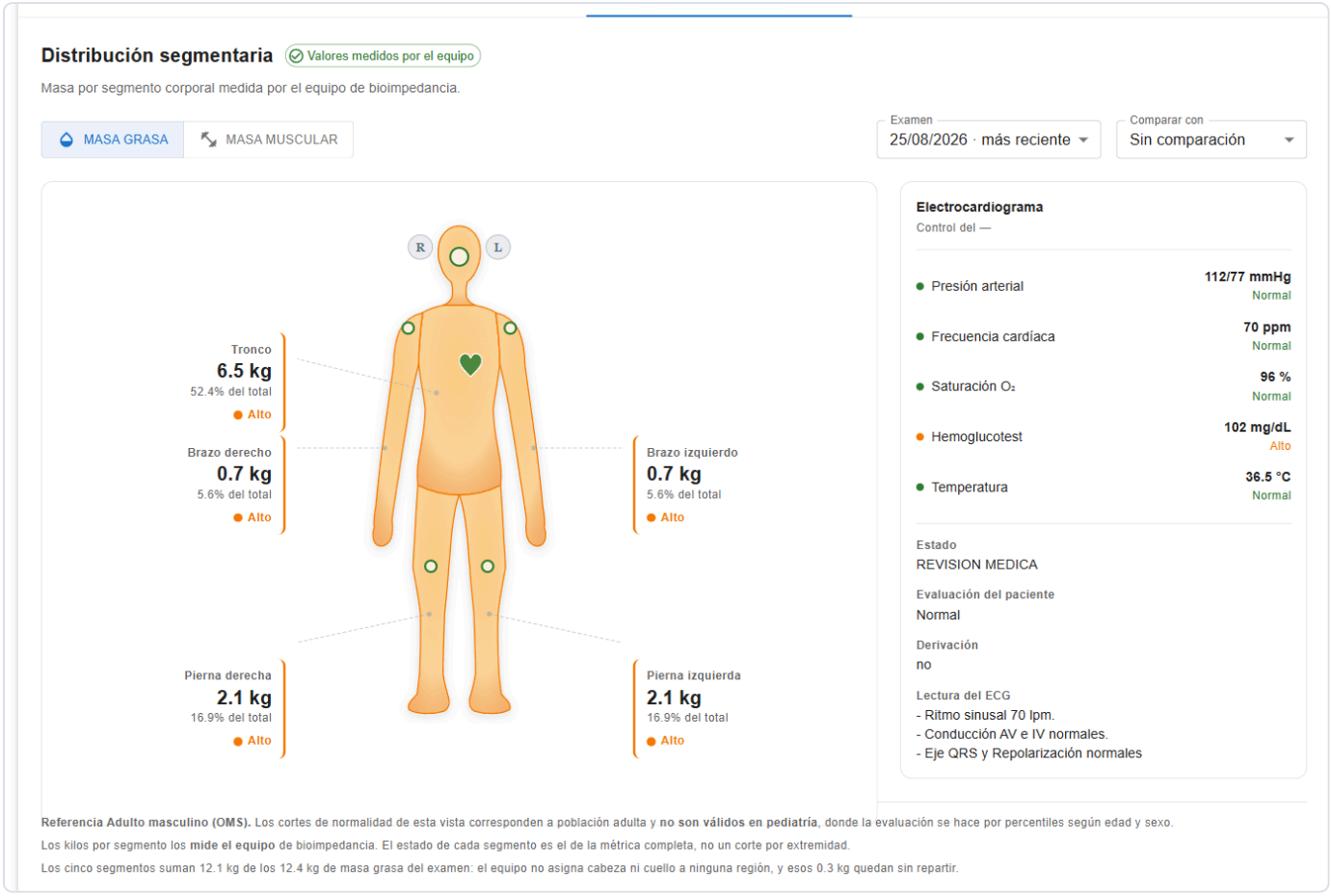
EDAD CORPORAL	GRASA VISCERAL	PUNTAJE CORPORAL
10 años	**4**	**75**
Frente a 11 de edad real. Su composición corporal es la de alguien algo menor: juega a favor.	La que rodea los órganos, en rango bajo. Es el dato con más peso para el riesgo metabólico.	El resumen que entrega el propio equipo, sobre 100.

> **CUANDO UNA MEDICIÓN NO ESTÁ**
>
> La ficha muestra un guion. No pone un cero: un cero parecería un resultado —«tienes cero minerales»— y lo que ocurre es otra cosa. **La ficha nunca rellena lo que no sabe**, y esa regla se cumple en las cinco pestañas.

4 Dónde está cada kilo

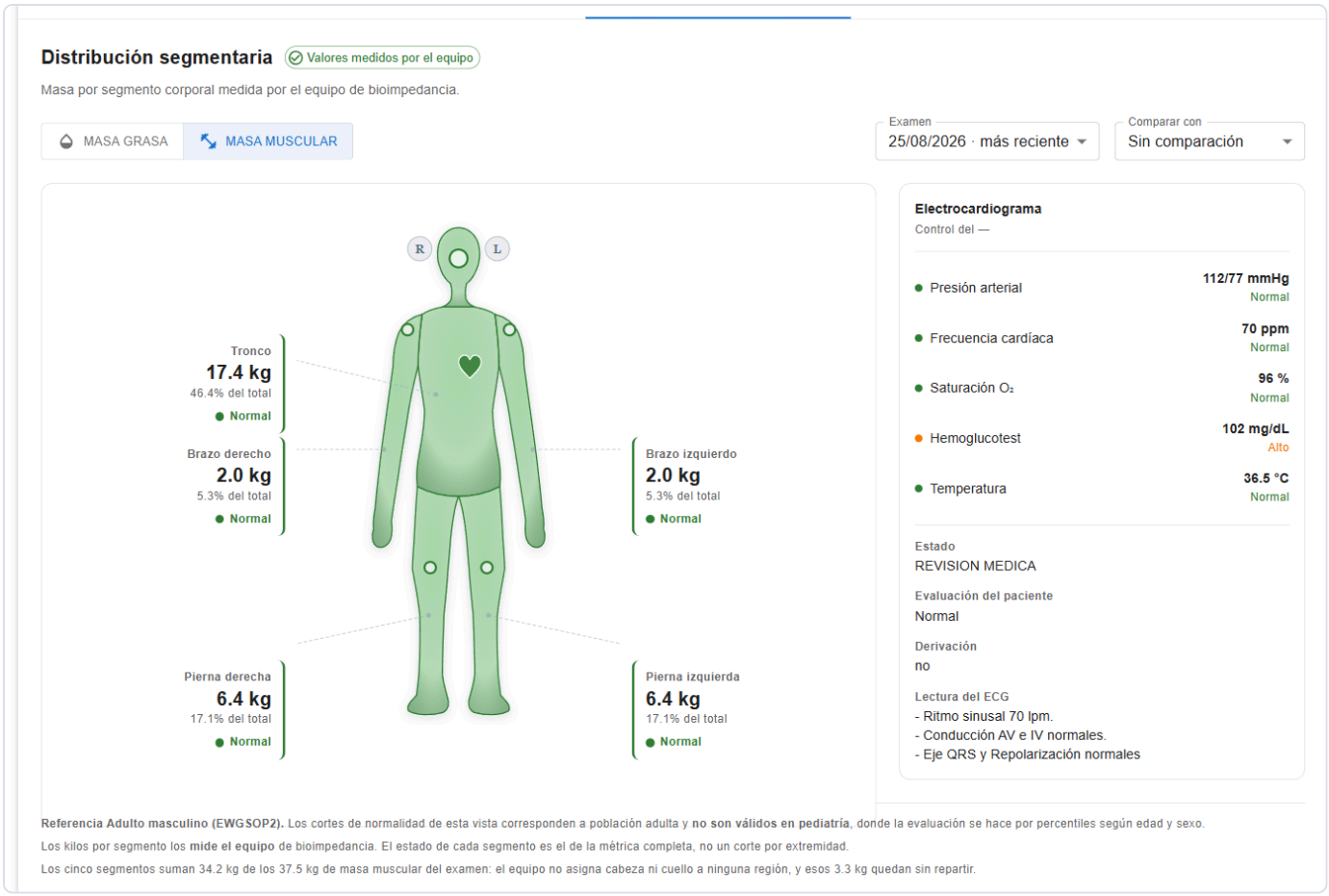
La misma información sobre una figura, para leerla de un vistazo.

Diez cifras por extremidad son exactas y difíciles de leer. Esta pantalla las pone sobre una silueta: cada región se colorea según su estado y muestra sus kilos y su porcentaje del total.



Masa grasa. Tronco 6,5 kg (52,4 % del total), 0,7 kg en cada brazo, 2,1 kg en cada pierna. Las marcas **R** y **L** están para que nadie lea el informe al revés: izquierda y derecha son las **del paciente**, no las de quien mira. A la derecha, el último control cardiológico.

El mismo cuerpo, mirado por masa muscular, cuenta otra historia:



Masa muscular. Tronco 17,4 kg, 2,0 kg en cada brazo, 6,4 kg en cada pierna. Todo en verde: la musculatura está en rango.

> **LAS DOS LECTURAS JUNTAS SON EL HALLAZGO**
>
> En este paciente la grasa aparece **Alto** y el músculo **Normal**. Es exactamente el caso que la pesa no distingue y que cambia la indicación: **no hay que «bajar de peso», hay que bajar grasa cuidando la masa muscular**. El plan del examen dice lo mismo con números.

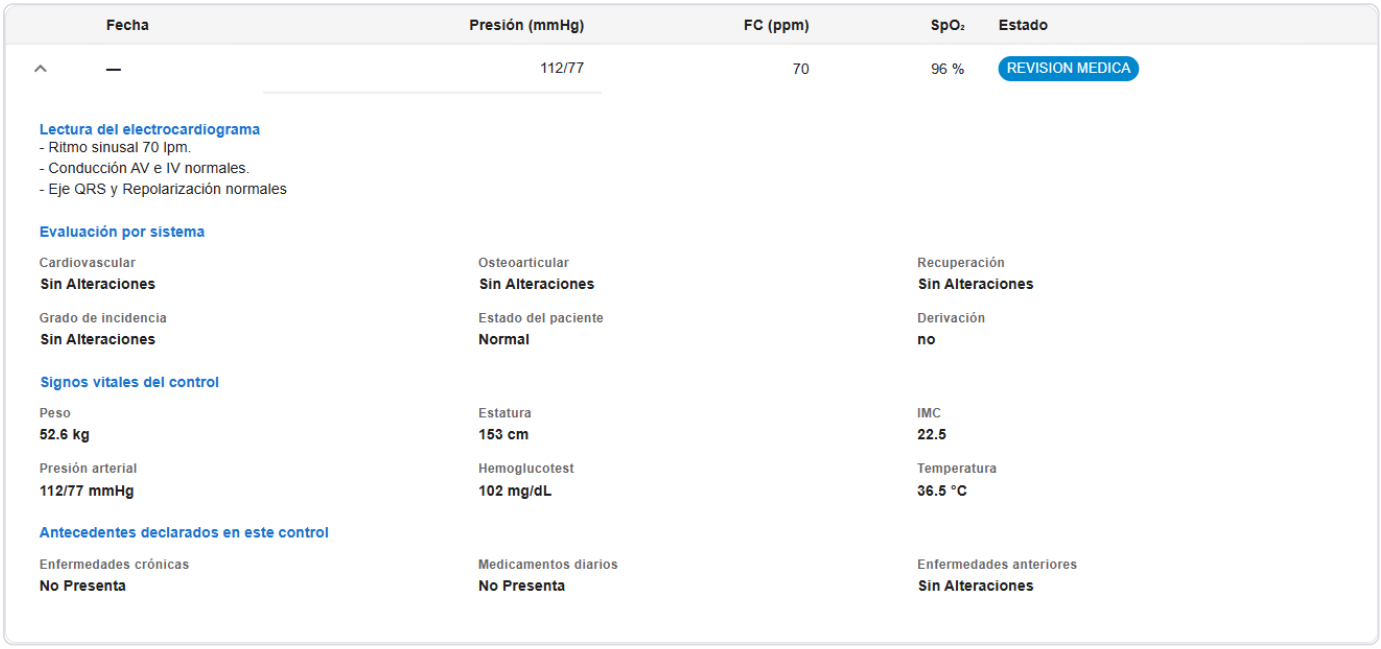
Comparar dos exámenes

Arriba a la derecha hay dos selectores: **Examen** y **Comparar con**. En el primer control aparece «Sin comparación», porque todavía no hay con qué comparar. Desde el segundo examen se elige uno anterior y la pantalla muestra, región por región, cuánto cambió. **Ahí la bioimpedancia deja de describir y empieza a medir el avance** del entrenamiento o del plan de alimentación.

5 Tu corazón

La lectura del médico, escrita, y no solo un «está todo bien».

Un electrocardiograma es un trazado que la mayoría de las personas no puede leer. Lo que esta pestaña te entrega no es el trazado: es **lo que el médico concluyó al mirarlo**, en palabras, más el detalle completo del control.



Un control real, desplegado. La lectura del electrocardiograma —ritmo, conducción, eje y repolarización—, la evaluación por sistema, los signos vitales de ese día y los antecedentes que se declararon. El estado indica en qué etapa del circuito está el examen.

Qué encuentras aquí

- **La lectura del trazado**, tal como la escribió el médico.
- **La evaluación por sistema**: cardiovascular, osteoarticular, recuperación tras el esfuerzo y grado de incidencia posterior.
- **La derivación**, cuando corresponde. Si el médico considera que hay que ver a un especialista, queda escrito aquí y no depende de que alguien te llame.
- **Los signos vitales de ese control**, para poder compararlos con los de otro día.

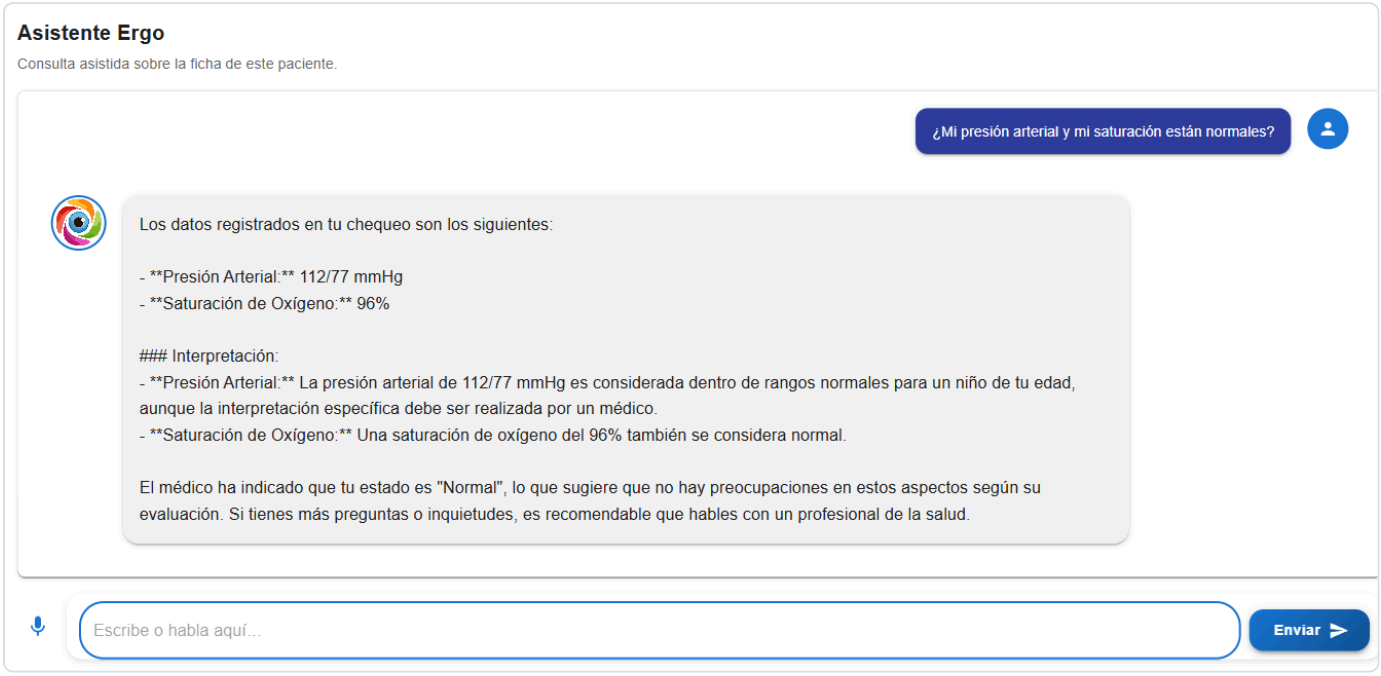
Arriba de la tabla hay tres gráficos —presión arterial, saturación con frecuencia cardíaca, y glicemia capilar— que dibujan la evolución control a control. **Con un solo control muestran un punto**; se llenan a medida que te vas tomando los siguientes.

> **POR QUÉ ESTO IMPORTA MÁS DE LO QUE PARECE**
>
> Las condiciones cardíacas que provocan un episodio grave durante el esfuerzo físico **no dan síntomas antes**. El electrocardiograma con lectura médica es lo que las detecta, y tenerlo guardado y comparable es lo que permite ver un cambio entre un año y el siguiente.

6 Pregúntale a tu ficha

Escribiendo o hablando, en tu idioma.

La última pestaña es un asistente que ya está mirando tu ficha. No hay que aprender a usarlo ni saber qué botón apretar: se le pregunta y responde con tus datos.



Una consulta real. Responde con los valores de tu control, los interpreta, y —fíjate— **recuerda que la interpretación específica la hace un médico**. Junto al cuadro de texto hay un micrófono: también se le puede hablar.

- **Ya sabe de quién es la ficha.** Al abrir la pestaña te saluda por tu nombre y trae el resumen de tu último chequeo.
- **Funciona hablando.** Lo que dictas se puede corregir a mano antes de enviarlo.
- **Responde sobre tus controles y sobre la lectura del médico.** Para lo de composición corporal, la pestaña de bioimpedancia es la que tiene el detalle.

Y todo esto en el teléfono

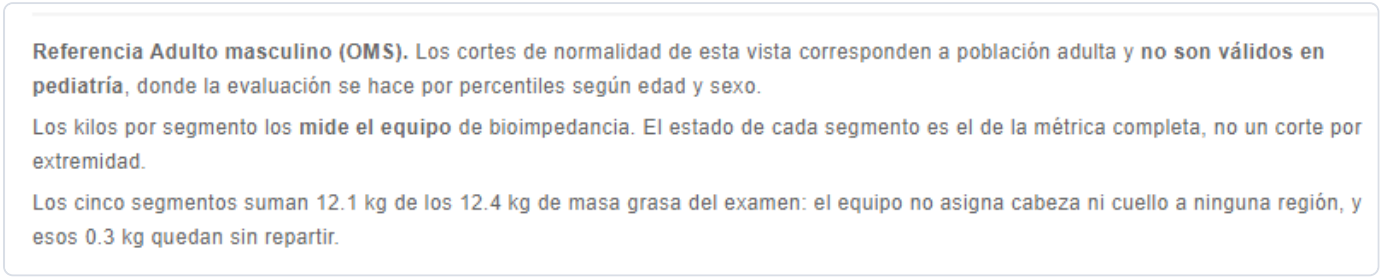


La misma ficha en el celular. Las cifras por región se ordenan una debajo de otra y la nota metodológica viaja con ellas. Útil en la cancha o en la sala de espera de la consulta.

7 Lo que la ficha te dice de sí misma

La letra chica, que aquí no es chica.

Debajo de la silueta hay tres líneas que conviene leer. No están escondidas ni en gris ilegible: están a la vista, porque cambian cómo se interpreta todo lo de arriba.



Tal como aparece en pantalla. Tres declaraciones: con qué referencia se pintaron los colores, de dónde salieron los kilos, y qué parte del total no se reparte.

Qué dice cada una

- **La referencia de los colores.** «Adulto masculino (OMS)» para la grasa, «Adulto masculino (EWGSOP2)» para el músculo. Y la advertencia que aplica a este paciente de 11 años: **los cortes de normalidad son de población adulta y no son válidos en pediatría**. En un niño, los kilos son la medición; el color es orientativo.
- **De dónde salen los kilos.** «Los kilos por segmento los mide el equipo». Si en algún examen el equipo no entregara alguna extremidad, la ficha la estimaría desde los totales y lo diría con esas palabras, marcando cada cifra estimada. **Nunca presenta un cálculo como si fuera una medición.**
- **Qué queda sin repartir.** «Los cinco segmentos suman 12,1 kg de los 12,4 kg de masa grasa del examen». Los 0,3 kg que faltan son cabeza y cuello, que el equipo no asigna a ninguna región. La ficha lo declara en vez de repartirlos por su cuenta.

> **POR QUÉ TE LO CONTAMOS**
>
> Un informe de salud que no dice de dónde salen sus números pide un acto de fe. Este dice cuál es la referencia, qué se midió, qué se calculó y qué no se sabe. **Puedes llevárselo a tu médico o a tu nutricionista y que lo revise.**

8 Para qué te va a servir

Lo que puedes decidir distinto con esta información.

Saber si el peso que bajaste salió de donde querías

Es la pregunta que la pesa no responde. Bajar cinco kilos perdiendo músculo y bajarlos perdiendo grasa se ven idénticos en la balanza y son resultados opuestos. Con dos exámenes, **la diferencia se ve en kilos**.

Entrenar sabiendo qué corregir

La vista por extremidad muestra si un lado va por detrás del otro. Para quien entrena, o vuelve de una lesión, es una indicación concreta de dónde poner el trabajo en vez de una impresión.

Poner la grasa visceral en la conversación

Es la que rodea los órganos y la que más se asocia a riesgo cardiovascular y metabólico. No se ve en el espejo y no se deduce del peso. Aquí es un número, y se puede seguir en el tiempo.

Llegar a la consulta con algo con qué trabajar

Llegar con la composición corporal medida, la lectura del electrocardiograma y el histórico de tus signos vitales cambia la conversación. El plan deja de partir de un promedio y parte de tus cifras.

Y no depender de tu memoria ni de una carpeta

Todo queda en la ficha. El año que viene, cuando te tomes el control siguiente, la comparación está hecha.

> **EN UNA FRASE**
>
> La pesa te dice si el número subió o bajó. Tu ficha te dice **qué cambió, dónde, qué dijo el médico y si vas en la dirección correcta**.

9 Qué es y qué no es

Preferimos decirlo aquí antes que en la consulta.

> **LA FICHA NO DIAGNOSTICA**
>
> La ficha **reúne y muestra** lo que se te midió, y la lectura del electrocardiograma la firma un médico. Pero la ficha en sí no diagnostica enfermedades, no reemplaza un examen de sangre y no sustituye una consulta. Es información para que quien te trate decida mejor.

Y para que sepas qué esperar:

- Los valores de bioimpedancia dependen de tu **estado de hidratación**. Un examen tomado deshidratado, después de entrenar o después de comer no es comparable con otro tomado en reposo. Para seguir la evolución, conviene repetir en condiciones parecidas.
- Los **rangos de normalidad son de población adulta**. En menores de 18 la ficha lo advierte y el color pasa a ser orientativo: quien interpreta es el pediatra.
- El equipo **no asigna cabeza ni cuello** a ninguna región, así que las cinco extremidades no suman el total del cuerpo. La ficha declara esa diferencia.
- La **«edad corporal»** y el **«puntaje corporal»** son indicadores propios del fabricante del equipo, útiles para motivar y seguir un avance. No son medidas clínicas estandarizadas.
- Los **gráficos de evolución** necesitan al menos dos controles. Con uno muestran un punto.

Cómo empezar

01

Coordinamos

Día, hora y lugar: tu casa, tu club o tu colegio. También en operativos para grupos.

02

Te atendemos

Llegamos con el equipamiento. Para la bioimpedancia, en ayunas y sin entrenar antes: es lo que hace comparables dos exámenes.

03

Recibes tu acceso

Tu usuario para entrar a la ficha, con los exámenes ya cargados.

Conversemos

Podemos atenderte a domicilio, o coordinar un operativo para tu club, colegio o empresa.

TELÉFONO Y WHATSAPP
+56 9 6114 9975

CORREO
contacto@ergosanitas.com

SITIO WEB
ergosanitas.com

Las imágenes de este documento son capturas reales de la plataforma, sobre la ficha de un paciente con un examen de bioimpedancia del 25/08/2026 y un control cardiológico. **El nombre y el RUT fueron reemplazados por datos ficticios**; el peso, la

estatura, la grasa, el músculo, la masa por extremidad, los signos vitales, la lectura del electrocardiograma y las respuestas del asistente son los valores verdaderos de esa ficha. Ergo SaniTas SpA.